Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Erreur médicamenteuse

Mauvais patient, mauvaise dose, mauvais médicament, mauvaise voie ou mauvaise heure, avant ou après la prise (adulte, enfant) : protéger, alerter, déclarer.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou somnolence anormale, respire mal, convulsion, malaise, gonflement du visage ou de la gorge après la prise.

1 · Je sécurise

- **Arrêter** toute autre prise ; rester près de la personne qui a pris le médicament.
- **Garder** blister, boîte, pilulier, gobelet et ordonnance : ne rien jeter.
- Piluliers peut-être inversés : **vérifier tous les piluliers** du tour avant de continuer.

2 · J'observe et je mesure

- **Qui** a pris **quoi**, **combien**, à **quelle heure** ?
- Médicament à risque ? insuline, antidiabétique, morphinique, anticoagulant, antiépileptique, psychotrope.
- Conscience, respiration, comportement ? Pouls, TA, SpO2 ; glycémie capillaire (AS/AP) si antidiabétique.

3 · J'agis

- Prévenir l'**IDE tout de suite** (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR), **même si tout va bien**.
- Doute sur la toxicité : **centre antipoison** de la région (numéro affiché), en lien avec l'IDE ou le médecin.
- Appliquer les consignes de surveillance reçues ; enfant (IME) : parents prévenus selon le PAI.
- **Déclaration interne** le jour même, erreur évitée de justesse comprise (fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »).

Je ne fais pas

- **Faire vomir**, donner du lait, de l'eau salée ou un « antidote ».
- Donner une autre dose pour « compenser » ou « rattraper ».
- Cacher ou minimiser l'erreur, corriger la traçabilité après coup.
- Donner un traitement « si besoin » sans validation de l'IDE (ou du médecin d'astreinte).

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Somnolence, respiration lente ou bruyante après morphinique, benzodiazépine ou neuroleptique.
- Insuline ou antidiabétique pris par erreur et glycémie < 0,70 g/L, sueurs ou confusion.
- Gonflement du visage, gêne respiratoire, malaise (allergie).
- Médicament à risque et IDE ou médecin non joignable tout de suite.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toute erreur**, même sans symptôme, dès qu'elle est découverte.
- Pouls < 50 ou > 120/min, PAS < 100 mmHg, SpO2 < 90 %, glycémie < 0,70 g/L.
- Vomissements, chute, comportement inhabituel dans les heures qui suivent.

Je surveille et je trace

- Surveiller conscience, respiration et comportement aux heures fixées par l'IDE ou le médecin.
- Tracer : médicament, dose, heure, personne, signes, qui a été prévenu, consignes reçues.
- Analyse en équipe, sans recherche de coupable ; rappel des 5B : bon patient, médicament, dose, voie, moment.

Mention de sécurité

Une erreur se signale tout de suite : c'est d'abord une urgence clinique possible, ensuite un événement à analyser sans chercher de coupable. On ne fait pas vomir, on ne compense pas.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments (2011, règle des 5B) ; centres antipoison (centres-antipoison.net) ; fiche socle DOTR « Qui signale quoi, à qui ? » (10/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES), art. 2 ; CASF L313-26.

Réf. DOTR-AS-ERRMED | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature